

(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS22222396087 1019

RONALDO BORTOLETTO ROCHA CAMPOS

IDADE: 60a PESO: 92 ALTURA: 186 PROFISSÃO: Comerciante

SINTOMAS: Desânimo - engasgo (frequente).

QUEIXAS: Apneia (prim. na hora almoço).

MEDICAMENTOS: Otelol - Bupropiona

MÉDICO: Drº Alberto -

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 5X (2 pilates - 3X musculação).

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: - JANTAR: 5 20

HORA QUE DORME: 22 HORA QUE ACORDA: 6:30 - 7h

COCHILO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO (X) EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO 3X semana

FUMO () SIM () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Nasal BANHEIRO: média 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 55,6 SPO2: 77%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Ha 20a. Uvulopalatotomy

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (X) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Aritmia

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS Dor lombar (crônica)

27/03/24 Avaliação

(infiltração 24/03/24)
marc N3bi + CPAP Elite

08/04/24 - Falamos d Srº Ronaldo, está dormindo em D.D.

Orientado pl lateralizar; ainda abrindo a boca.

18/04/24 P= 7cmH₂O

IAH= 11,3 elh

m. de uso: 3h 50min

fluxo: 13,9 l/min (mediana)

35,8 l/min (percentil)

Relata que sempre que abre a boca e tem escape de ar acaba acordando, isso acontece varias vezes a noite

Natasha

02/05

P= 7cmH₂O

IAH= 5,5 elh

m. de uso: 2h 50'

P= 7cmH₂O

IAH= 4,6

10/04/25

P=7,4 cmH₂O

IAH=9,1 cmH₂O

AO: 4,4 e/h

IA: 4,3 e/h

m. de uso: 5 e 8

fuga: 22,6 l/m

Dilata que sente
que precisa puxar
o ar ao utilizar

Deixo rampa 5m com início 7,4 cmH₂O
P=8,4 cmH₂O e observe.

Natacha

14/04
25

P= 8,4 cmH₂O

IAH= 2,4 e/h

m. de uso

↓ pl 5m

(min 7,4 cmH₂O) → ele n suportou

↓ a P min = 6,0 cmH₂O

mantendo 8,4 cmH₂O

Sua claudicia

Clinica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Ronaldo Bortoleto Rocha Campos

EXAME nº: 5527-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 04/03/2024

IDADE: 60 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 21h15min e concluído às 05h49min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 165 minutos. O tempo total de sono foi de 311 minutos (05h11min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 61,1%. A distribuição do sono mostrou 55,3% de estágio 1, 29,7% de estágio 2, 2,3% de estágio 3 e 9,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 183,5 minutos em vigília, ocorreram 359 microdespertares (índice: 69,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 30,1/hora, sendo 0,2 apneia/hora e 29,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 30,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 93% e a mínima de 77%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa shallow (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,6 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (30,1/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (30,1/hora), ritmo cardíaco sinusal, despertares e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 51; máxima: 64 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min) – ele usou um comprimido de Patz 5 mg às 21h15min. A latência para o sono REM estava alongada (165 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 61,1%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 69,3/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (55,3%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 2 (29,7%; normal: 45-55%), 3 (2,3%; normal: 10-12%) e REM (9,8%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (0,8/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Dr. Alberto Jorge

Remesar Lopez

Médico
CRM 69.730

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, si 51 e 52

Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos

Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62.858

Clínica
DR. ALBERTO
psiqui

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Ronaldo Bortoletto Rocha Campos
EXAME nº: 5527
SOLICITADO POR: Dr. Luiz Eduardo Miguel
DATA: 13/11/2023
IDADE: 60 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h34min e concluído às 06h11min. A latência para o sono foi de 26 minutos e a latência para o estágio REM, de 164 minutos. O tempo total de sono foi de 397 minutos (06h37min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 78,3%. A distribuição do sono mostrou 43,1% de estágio 1, 35,9% de estágio 2, 2,3% de estágio 3 e 18,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 83,5 minutos em vigília, ocorreram 308 microdespertares (índice: 46,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,3/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 55,6/hora, sendo 10,4 apneia/hora e 45,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 63,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 90%, sendo a média de 90% e a mínima de 77%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono

TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (55,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (63,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 44; máxima: 70 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 26 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (164 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 78,3%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 46,5/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (43,1%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 2 (35,9%; normal: 45-55%), 3 (2,3%; normal: 10-12%) e REM (18,8%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (2,3/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 12 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Ronaldo Bortoloto Rocha Campos

Solicito a compra do CPAP para
o tratamento da síndrome da apnéia do sono.

Ele usou a máscara nasal Mirage
Ativa shallow e a pressão estabelecida foi
de 6,6 cm H₂O.

Diagn: G47.3

Att,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

STC, 27/3/24

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008